

Miomas uterinos

1. Introducción y relevancia clínica

Los **miomas uterinos** (también llamados **leiomiomas**) son **tumores benignos del músculo liso del útero** y representan **la neoplasia ginecológica más frecuente en la mujer en edad fértil**.

En Chile, se estima que afectan entre el **20 y el 40% de las mujeres mayores de 35 años**, aunque muchas son asintomáticas.

Su importancia clínica radica en que pueden causar **sangrado uterino anormal, infertilidad, abortos recurrentes y síntomas compresivos**, además de ser una **causa frecuente de histerectomía**.

□ En EUNACOM suelen preguntar:

- Tipos anatómicos de miomas y su localización.
 - Manejo médico vs quirúrgico según síntomas y edad.
 - Diferencias entre mioma submucoso y endometrial.
 - Diagnóstico por ecografía transvaginal.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

Los miomas son tumores **hormonodependientes**, formados por **células musculares lisas** y **tejido conectivo** del miometrio.

a. Factores hormonales

- Crecen bajo el estímulo de **estrógenos** y **progesterona**.
- Aumentan de tamaño durante el embarazo y disminuyen tras la menopausia.

b. Factores de riesgo

- Menarquia precoz.

- Nuliparidad.
- Obesidad.
- Antecedentes familiares.
- Raza afrodescendiente.
- Exposición prolongada a estrógenos endógenos o exógenos.

c. Fisiopatología

El crecimiento miomatoso puede alterar la **contracción uterina**, la **vascularización endometrial** y la **implantación embrionaria**, produciendo **hemorragia uterina, infertilidad y dolor pélvico**.

3. Clasificación anatómica

Según la **localización dentro del útero**, los miomas se dividen en:

Tipo	Localización	Características clínicas
Submucoso	Bajo el endometrio, protruye hacia la cavidad uterina	Produce sangrado uterino anormal, infertilidad, abortos
Intramural	Dentro del espesor del miometrio	Aumenta tamaño uterino, sangrado, dolor pélvico
Subseroso	Bajo la serosa uterina, protruye hacia la cavidad abdominal	Síntomas compresivos (vejiga, recto)
Pediculado	Unido por un pedículo (submucoso o subseroso)	Riesgo de torsión o necrosis

Cervical En cuello uterino

Dificulta parto o menstruación,
sangrado

- El **submucoso** es el tipo más sintomático y más asociado a **metrorragia e infertilidad**.

4. Clínica

a.

Síntomas principales

1. **Sangrado uterino anormal (SUA):** hipermenorrea, menorragia o metrorragia.
2. **Síntomas compresivos:** polaquiuria, tenesmo rectal, constipación.
3. **Dolor pélvico:** por distensión, degeneración o torsión de mioma pediculado.
4. **Infertilidad y aborto recurrente:** por distorsión de cavidad endometrial.
5. **Aumento del volumen abdominal:** hallazgo típico en miomas grandes.

b.

Signos físicos

- Útero aumentado de tamaño, duro, irregular (“en empedrado”).
- Movilidad conservada (a diferencia de tumores malignos).

5. Diagnóstico diferencial

Cuadro	Diferencia clave
Adenomiosis	Útero difusamente aumentado, doloroso, sin masa definida

Cáncer endometrial	Metrorragia posmenopáusica, endometrio engrosado en eco
Embarazo molar o gestación	β -hCG positiva
Tumores ováricos	Masa separada del útero en ecografía

6. Exámenes complementarios

a.

Ecografía transvaginal

- Examen de elección.
- Permite determinar tamaño, número y localización.
- Imagen típica: masa hipoecoica bien delimitada.

b.

Histerosonografía / histeroscopia

- Evaluación directa de cavidad uterina.
- Útil para miomas submucosos e infertilidad.

c.

Resonancia magnética (RM)

- Para mapeo prequirúrgico en casos complejos o úteros voluminosos.

d.

Hemograma y ferritina

- Para evaluar anemia por hemorragia crónica.
-

7. Criterios diagnósticos (MINSAL / Guía AUGESUA, 2022)

Diagnóstico clínico y ecográfico de **miomatosis uterina**:

1. Presencia de **masa uterina bien delimitada** en ecografía.
 2. Tamaño uterino aumentado o irregular.
 3. Sangrado uterino anormal o síntomas compresivos.
 4. Exclusión de otras causas de SUA.
-

8. Tratamiento

El manejo depende de:

- Edad y deseo reproductivo.
 - Tamaño, número y localización de los miomas.
 - Síntomas (sangrado, dolor, compresión).
-

A.

Tratamiento médico

1. Indicaciones:

- Miomas pequeños o asintomáticos.
- Mujeres cercanas a menopausia.

- Deseo de conservar fertilidad.

2. Opciones:

Fármaco	Mecanismo	Efecto
Anticonceptivos orales combinados	Estabilizan endometrio	Disminuyen sangrado
Progestágenos (acetato de medroxiprogesterona)	Suprimen proliferación endometrial	Controlan metrorragia
Análogos de GnRH (leuprolida, goserelina)	Inhiben eje HHO → hipoestrogenismo	Reducen tamaño (30–50%) temporalmente
DIU liberador de levonorgestrel (Mirena®)	Efecto local antiproliferativo	Reduce metrorragia
Antifibrinolíticos (ácido tranexámico)	Disminuyen sangrado menstrual	En uso episódico

□ Los análogos de GnRH se usan como **tratamiento prequirúrgico** o **punteo a la menopausia**, pero no a largo plazo por riesgo de pérdida ósea.

B.

Tratamiento quirúrgico

1. Indicaciones:

- Sangrado uterino anormal refractario.
- Anemia significativa.
- Infertilidad o abortos repetidos.
- Crecimiento rápido o tamaño >12 semanas gestación.

- Síntomas compresivos severos.

2. Opciones quirúrgicas:

Procedimiento	Descripción	Indicaciones
Miomectomía	Extirpación selectiva de miomas conservando útero	Deseo de fertilidad
Histeroscopia operatoria	Resección de miomas submucosos	Mioma único y pequeño (<4 cm)
Histerectomía	Extirpación total del útero	No deseo de fertilidad o múltiples miomas
Embolización de arterias uterinas	Oclusión vascular selectiva	Alternativa conservadora en mujeres seleccionadas

En mujeres jóvenes con deseo de embarazo, se prioriza la **miomectomía**.
En posmenopáusicas o sin deseo gestacional, la **histerectomía** es definitiva.

9. Complicaciones

Tipo	Descripción
Anemia ferropénica	Por metrorragia crónica
Degeneración miomatosa	Dolor agudo, fiebre, necrosis central
Torsión	En mioma pediculado subseroso

Infertilidad

Por alteración endometrial

**Degeneración
sarcomatosa**

<1% (rara, sospechar crecimiento rápido
posmenopausia)

10. Seguimiento

- Evaluación clínica y ecográfica anual.
 - Control hematológico (hemoglobina, ferritina).
 - Reevaluar tamaño y síntomas tras tratamiento.
 - En tratamiento médico: control cada 6–12 meses.
-

11. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. Miomas = **tumores benignos del músculo uterino**, dependientes de estrógenos.
2. **Submucosos** → **metrorragia e infertilidad**.
3. **Ecografía transvaginal** = examen de elección.
4. **Tratamiento médico**: ACO, progestágenos, DIU-LNG, GnRH.
5. **Tratamiento quirúrgico**: miomectomía o histerectomía según fertilidad.
6. En menopausia, los miomas **tienden a involucionar**.
7. **Sangrado posmenopáusico o crecimiento rápido** → **sospechar sarcoma**.



Errores comunes

- No tratar anemia asociada.
 - Realizar histerectomía en mujeres jóvenes sin evaluación de fertilidad.
 - Usar GnRH por más de 6 meses sin control óseo.
 - No diferenciar mioma submucoso (causa de infertilidad).
 - No controlar crecimiento del mioma durante seguimiento.
-

12. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. Los **miomas uterinos** son tumores benignos del miometrio dependientes de estrógenos.
2. Pueden causar **sangrado uterino anormal, dolor pélvico e infertilidad**.
3. La **ecografía transvaginal** es el método diagnóstico de elección.
4. El manejo depende de **edad, síntomas y deseo reproductivo**.
5. **Tratamiento médico** controla síntomas; **quirúrgico** se reserva para refractarios.
6. **Mioma submucoso = mayor sangrado y riesgo de infertilidad**.
7. **Crece en posmenopausia o rápido → sospechar malignidad (sarcoma)**.